

Hemorragia pós-parto · 4T

HPP primária: perda "e 500 mL no vaginal ou "e 1000 mL na cesárea (ou qualquer perda com repercussão). Atonia é a causa nº 1 — massageie e use uterotônicos cedo.

Os 4T

T | Causa | Conduta-chave

Tônus | Atonia uterina | Massagem bimanual + ocitocina / metilergometrina / misoprostol

Trauma | Laceração, ruptura, hematomas | Revisão de canal + sutura

Tecido | Restos placentários / acretismo | Remoção / curetagem / acretismo = centro

Trombina | Coagulopatia | Protocolo de transfusão / fatores

Escalonamento

- Ocitocina EV é 1ª linha; evitar ergometrina em HAS/pré-eclâmpsia
- Balão intrauterino (Bakri) se atonia refratária
- Suturas de compressão (B-Lynch), ligadura vascular, embolização
- Histerectomia como último recurso para salvar a vida

Prevenção

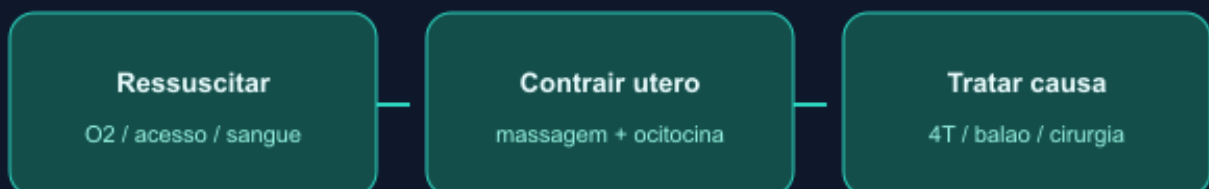
Lembre - Prevenção

Manejo ativo do 3º período (ocitocina após ombro anterior / dequitação conforme protocolo) reduz HPP.

Simultâneo: ressuscitar, contrair o útero e tratar a causa dos 4T.

HPP - conduta inicial

ABC + utero + causa (4T)



Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Útero contraído + sangramento persistente !' procure laceração de colo/vagina ou coagulopatia; não 'só mais ocitocina'.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Hemorragia pós-parto: memorizar 4T (tom, trauma, tecido, trombina) e tratar a causa enquanto reanima.

HPP - 4T

Causas clássicas de prova

- 1 Tone - atonia uterina
- 2 Trauma - laceracao / utero / hematoma
- 3 Tissue - restos placentarios / acretismo
- 4 Thrombin - coagulopatias

Tone é a causa #1 (~70%)

4T !' conduta inicial

T | Pista clínica | Conduta

Tone | Útero amolecido, fundo alto | Massagem + ocitocina ± uterotônicos

Trauma | Útero contraído, sangramento ativo | Revisão de canal + sutura

Tissue | Placenta incompleta / lóquios | Revisão de cavidade / curetagem

Thrombin | Sangramento difuso, exams alterados | Corrigir coagulação / protocolo

Definição útil

Lembre - Definição útil

HPP precoce: perda excessiva nas primeiras 24 h. Em prova, atonia vem primeiro — massageie e use uterotônicos enquanto avalia os outros T.

Não esquecer no ABCD obstétrico

- Acesso calibroso ×2, cristaloides, tipagem/RH, hemocomponentes
- Esvaziar bexiga; compressão bimanual se necessário
- Se falha: balão, ligaduras, embolização, histerectomia de salvamento